



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SMS

OFÍCIO Nº SMS-OFI-2023/32745

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2023.

Assunto: NORMATIZAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO. ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Considerando a necessidade de instituir a linha de cuidado do Transtorno do Espectro do Autismo, a Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde, a Subsecretaria de Hospitais, Urgência e Emergência e a Subsecretaria Geral da SMS exaram a Nota Técnica: Fluxo para avaliação, diagnóstico e tratamento de crianças com alterações no desenvolvimento.

Cordialmente,

RENATO CONY SERODIO
Subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Matrícula: 3243748
S/SUBPAV

LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO
Superintendente de Atenção Primária
Matrícula: 3243623
S/SUBPAV/SAP

FERNANDA ADAES BRITTO
Subsecretária Geral
Matrícula: 3243508
S/SUBGERAL

HUGO MARQUES FAGUNDES JUNIOR
Superintendente de Saúde Mental
Matrícula: 1623735
S/SUBHUE/SSM



Assinado com senha por RENATO CONY SERODIO - 12/09/2023 às 16:54:00, LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO - 12/09/2023 às 16:57:55, HUGO MARQUES FAGUNDES JUNIOR - 12/09/2023 às 18:58:10 e FERNANDA ADAES BRITTO - 12/09/2023 às 19:29:46.
Documento Nº: 3604635-6484 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3604635-6484>



SMSOFI202332745A

SIGA

NOTA TÉCNICA: FLUXO PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO

(Atualização da Nota Técnica SMS-OFI-2023/26745)

CONCEITO E EPIDEMIOLOGIA

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um distúrbio complexo do neurodesenvolvimento que afeta a estrutura e a função do cérebro, levando a um desenvolvimento atípico. Caracteriza-se por dificuldades na comunicação e interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, e pode apresentar um repertório restrito de interesses e atividades (MS, 2021). A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 (APA, 2014) destaca que as manifestações do TEA variam em intensidade, com necessidade de diferentes graus de suporte que vão desde intervenções pontuais até casos que necessitam de apoio contínuo ao longo da vida. **O diagnóstico precoce é crucial, pois permite intervenções terapêuticas que podem melhorar significativamente a qualidade de vida do indivíduo.**

Esta Nota Técnica institui o protocolo de atendimento às pessoas com alteração nos marcos do desenvolvimento infantil na rede de atenção à saúde do município do Rio de Janeiro.

LINHA DE CUIDADO DA CRIANÇA COM SUSPEITA DE TEA

Atenção Primária à Saúde

Cabe aos profissionais das equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária (médicos e enfermeiros) o acompanhamento rotineiro das crianças de sua área adscrita, com atenção à avaliação do desenvolvimento infantil.

Todas as crianças de 0 a 9 anos devem ser avaliadas sob a ótica do instrumento de Vigilância do Desenvolvimento Infantil, disponibilizado na Caderneta de Saúde da Criança do Ministério da Saúde.

Diante da prevalência do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e do impacto positivo da estimulação precoce na maioria dos casos, é necessária a ampliação da capacidade de detecção neste nível de atenção. Para isso, faz-se necessário complementar a investigação por meio do uso de ferramentas específicas para Triagem do Espectro do Autismo. Deste modo, orienta-se:

Estratégias para crianças entre 18 e 30 meses:

Aplicação da ferramenta de Triagem para Autismo M-CHAT-R (Anexo 1).

Todas as crianças nesta faixa etária devem ser submetidas a aplicação da escala M-CHAT-R obrigatoriamente em pelo menos uma consulta entre 18 e 30 meses, podendo ser antecipada para 16 meses em casos de alta suspeição.



Assinado com senha por RENATO CONY SERODIO - 12/09/2023 às 19:17:13 e LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO - 12/09/2023 às 19:18:10.
Autenticado digitalmente por RENATO CONY SERODIO - 12/09/2023 às 19:17:24.
Documento Nº: 3604635.26514968-3565 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3604635.26514968-3565>



SMSOFI202332745A

O seguimento desses casos incluirá a manutenção do acompanhamento na APS, acrescido de avaliação multiprofissional para elucidação diagnóstica e estimulação precoce para os casos em que há evidência de suspeita moderada ou alta.

- 0-2 pontos: Prosseguir com o acompanhamento rotineiro na APS
- 3-7 pontos (Risco Moderado para autismo) ou 8 ou mais pontos (Alto Risco):
 - Encaminhar para *Avaliação Multiprofissional - suspeita de Autismo* no SISREG;
 - Manter o acompanhamento na APS em consultas de rotina na APS.

Estratégia para crianças entre 4 e 11 anos:

Nessa faixa etária, não há orientação de rastreamento de rotina de TEA nas consultas de puericultura, porém deve ser mantida a vigilância do desenvolvimento e o acompanhamento das demandas que surgirem relacionadas ao desenvolvimento e comportamento. Se estiverem presentes alterações na interação social, linguagem ou comportamentos estereotipados ou repetitivos, essas alterações precisam ser exploradas, especialmente nos casos em que não foi feito o M-Chat na idade recomendada. O quadro abaixo apresenta as alterações encontradas conforme a faixa etária. Além disso, para crianças entre 4 e 11 anos, deve ser usado o instrumento AQ-10, com o objetivo de qualificar melhor a suspeição de TEA.

Domínios	Até 5 anos	5 a 11 anos	Acima de 11 anos
Linguagem	Atraso na fala, repetição de palavras (ecolalia), uso inadequado de pronomes, regressão ou perda de fala.	Fala limitada, tom monótono, discurso repetitivo dominado por interesses próprios, tendência a monólogo.	Fala limitada, tom monótono, discurso dominado por interesses próprios, respostas rudes, tendência ao monólogo.
Respondendo a outras pessoas	Respostas reduzidas a estímulos sociais (não responder quando chamado), ausência de sorriso social, rejeição de carinho, excesso de negação ao que solicitam.	Respostas reduzidas/inadequadas a expressões faciais, dificuldade em compreender intenções, não resposta a chamados, literalidade, respostas negativas ao que solicitam.	Respostas rudes/inadequadas, dificuldade em compreender intenções e contexto social, intolerância à invasão de seu espaço pessoal, isolamento social, literalidade (dificuldade de compreender sarcasmo ou metáforas).
Interagindo com outras pessoas	Ausência de interesse social, brincar sozinho, não reagir a emoções alheias, intolerância a que pessoas invadam seu espaço, aproximação desajeitada/inadequada.	Dificuldade em interações sociais e brincadeiras com pares, inadequado quando interessado, percebe inadequadamente o espaço pessoal, interesses que não se conformam com os de outras crianças.	Dificuldade na interação social, podendo haver maior facilidade de interação com adultos ou com crianças mais novas, ausência do hábito de se despedir ou de saudar outras pessoas, isolamento social.
Contato visual, apontar e outros gestos	Contato visual reduzido, dificuldade em seguir apontamentos ou em chamar atenção.	Uso restrito de gestos, expressões faciais e contato visual.	Gestos pouco integrados ao discurso e às expressões faciais.



Domínios	Até 5 anos	5 a 11 anos	Acima de 11 anos
Ideias e imaginação	Pouca brincadeira imaginativa ou criativa.	Redução ou ausência de jogos imaginários ou criatividade, comentários inapropriados segundo contexto social ou hierarquias.	Histórico de redução ou ausência de jogos imaginários ou criatividade.
Interesses incomuns ou restritos e/ou comportamentos repetitivos	Comportamento repetitivo e interesses restritos, hiperfocos incomuns, estereotípias, fixação em hábitos, intolerância a mudanças, hiper ou hiporresponsividade sensorial.	Interesses excessivamente focados, comportamentos repetitivos, dificuldade com mudanças, estereotípias, expectativas rígidas sobre como os outros devem se portar, seletividade alimentar.	Interesses altamente específicos, comportamentos repetitivos, intolerância a mudanças de rotina, passatempos específicos, tendência a rotinas e regras, hipo/hiperreatividade sensorial, seletividade alimentar.

Fonte: Adaptado de RIO DE JANEIRO, 2018.

Para maior detalhamento, ver o Guia de Referência Rápida de Saúde Mental na Infância (https://www.subpav.org/aps/uploads/publico/repositorio/saude_mental_na_infancia.pdf).

Aplicação da ferramenta de investigação Escala AQ-10 (Anexo 2)

- 0-5 pontos: Prosseguir com cuidados primários
- 6-10 pontos: Encaminhar para *Avaliação Multiprofissional - suspeita de Autismo* no SISREG.

OBS: Para as crianças entre 30 meses e 4 anos não há ferramentas de simples aplicação para a APS. Deve-se, portanto, encaminhar para *Avaliação Multiprofissional - suspeita de Autismo* no SISREG aquelas com alteração do desenvolvimento identificadas na ferramenta de Vigilância de Desenvolvimento Infantil contida na Caderneta de Saúde da Criança.

Investigação complementar na APS

Todas as crianças que apresentam suspeita de autismo com atraso na linguagem e suspeita de perda auditiva de qualquer natureza devem realizar exame de Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) via SISREG *Reabilitação Auditiva*.

Equipe Multidisciplinar de Desenvolvimento Infantil (E-Multi DI)

As equipes multiprofissionais com foco no Desenvolvimento Infantil são compostas minimamente por Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Pediatra/Neuropediatra e Psicólogo. Sua função é de realizar o seguimento das crianças com alterações nos marcos do desenvolvimento, contemplando a avaliação longitudinal com o objetivo de elucidação diagnóstica, início precoce da estimulação precoce e orientação dos familiares e responsáveis.

As crianças cujo diagnóstico de TEA foi descartado pela E-Multi DI serão redirecionadas às equipes de APS para acompanhamento rotineiro e vigilância. Para casos de dúvida diagnóstica e/ou necessária a avaliação complementar em saúde mental, a E-Multi DI poderá discutir o caso com o CAPSi de referência da área.



As crianças com diagnóstico definitivo e que necessitam de reabilitação deverão ser contrarreferenciadas para a APS a fim de que sejam encaminhadas via SISREG para *Consulta em Reabilitação Intelectual - Pediatria*.

Centros de Atenção Psicossocial Infantil

Cabe à equipe do CAPSi avaliação de casos com alta suspeição pela APS, com vistas à confirmação diagnóstica e emissão de laudo definitivo da condição avaliada.

Crianças cujo transtorno global do desenvolvimento seja descartado serão redirecionadas às equipes de atenção primária para acompanhamento e vigilância. Para as crianças com diagnóstico definitivo e que necessitem de reabilitação, serão contra referenciadas para a APS a fim de que sejam encaminhadas via SISREG para *Consulta em Reabilitação Intelectual - Pediatria*.

Centros Municipais de Reabilitação

Cabe aos CMR o acolhimento e acompanhamento de longo prazo de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo. As equipes multidisciplinares dos centros de reabilitação são responsáveis por instituir terapia integral em parceria com a equipe de Saúde da Família e demais equipamentos públicos de saúde e garantia de direitos.

REGULAÇÃO AMBULATORIAL DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE TEA

1) Avaliação Multiprofissional - Suspeita de Autismo

A Avaliação Multiprofissional - Suspeita de Autismo é realizada pelos profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) e pelas Equipes Multidisciplinares de Desenvolvimento Infantil (E-Multi DI), com a finalidade de avaliar as crianças com transtornos do desenvolvimento identificadas pelas equipes de APS. Devem ser inseridas nessa fila:

- Crianças avaliadas pela APS com suspeita de alteração do desenvolvimento conforme fluxo estabelecido nesta Nota Técnica;
 - M-CHAT-R = 3-7 pontos (Risco Moderado para autismo) ou 8 ou mais pontos (Alto Risco) em crianças de **16 a 30 meses**;
 - AQ-10 = 6-10 pontos em crianças de **4 a 11 anos**;
 - Alterações nos marcos de desenvolvimento identificadas na ferramenta de Vigilância de Desenvolvimento Infantil contida na Caderneta de Saúde da Criança em crianças de **31 meses a 4 anos incompletos**.
- Crianças em fila na “*Consulta em Neurologia - Pediatria*”, “*Consulta em Reabilitação Intelectual - Pediatria*”, “*Consulta em Fonoaudiologia - Infantil*”, “*Consulta em Terapia Ocupacional*”, “*Consulta em Saúde Mental - Infante juvenil*” e “*Consulta em Psiquiatria - Infante juvenil*” sem diagnóstico, cuja descrição do motivo de encaminhamento contemple alterações sugestivas de Transtorno do Espectro do Autismo.



**CONTEÚDO DESCRITIVO MÍNIMO DO ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO
MULTIPROFISSIONAL - SUSPEITA DE AUTISMO**

1. Descrição do quadro atual (idade de início, evolução dos sintomas e as áreas de atividades com prejuízo). Descrever marcos do desenvolvimento atrasados e os já adquiridos;
2. Inserção no ambiente escolar (regular ou especial) e acompanhamento em sala de recurso (sim ou não). Se sim, descreva;
3. Apresenta comorbidades neurológicas ou psiquiátricas (sim ou não). Se sim, descreva;
4. Pontuação na escala M-CHAT-R ou AQ-10;
5. Presença de padrões repetitivos e restritos de comportamento, atividades ou interesses;
6. História familiar de deficiência intelectual ou doenças raras (sim ou não). Se sim, descreva o quadro e grau de parentesco;
7. Terapias de reabilitação realizadas (sim ou não). Se sim, descreva;
8. Tratamento medicamentoso em uso ou já realizado (sim ou não). Se sim, descreva quais medicações e posologia;
9. Realiza acompanhamento em serviço especializado em Saúde Mental (sim ou não). Se sim, descreva;
10. Informar resultados de exames complementares para diagnóstico diferencial.

2) Consulta em Neurologia - Pediatria

Reservada para avaliação de casos de criança que apresentem crises convulsivas febris atípicas ou crises afebris; suspeita ou diagnóstico confirmado de doenças neuromusculares, doenças do neurônio motor, distúrbios do movimento, doenças desmielinizantes, síncope, cefaléia, vertigem de origem central, macrocrania ou microcrania associadas e outras desordens neurológicas de caráter progressivo. Casos cirúrgicos deverão ser encaminhados para neurocirurgia via SER.

3) Consulta em Reabilitação Intelectual - Pediatria

Está indicada para crianças com **diagnóstico definitivo** de Transtorno do Espectro do Autismo e/ou Deficiência intelectual (retardo mental) com indicação de acompanhamento por equipe multiprofissional. Este acompanhamento é ofertado pelos Centros de Reabilitação municipais, contratualizados e/ou conveniados. Devem ser encaminhadas apenas crianças com diagnóstico conclusivo após avaliação nos CAPSi ou E-Multi DI, ou com diagnóstico definitivo realizado por outro médico assistente.

4) Consulta em Psiquiatria Infantojuvenil

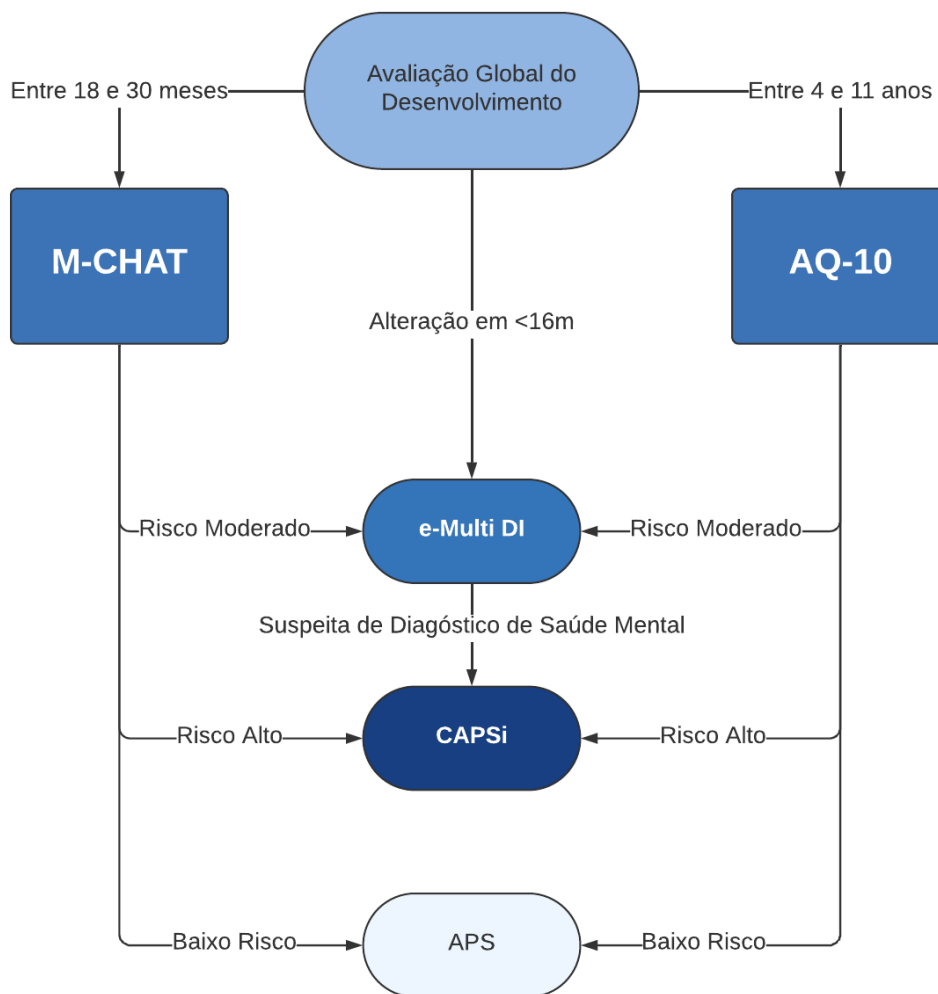
Devem ser encaminhadas para Psiquiatria infantojuvenil via SISREG as crianças com suspeita ou confirmação de diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), desde de que a equipe de saúde da família não considere ser possível seu acompanhamento na APS.

AGENDAMENTO



O agendamento para as especialidades Avaliação Multiprofissional - suspeita de autismo, **Consulta em Neurologia - Pediatria, Consulta em Reabilitação Intelectual - Pediatria e Consulta em Psiquiatria Infantojuvenil** deve ser centralizado, sendo responsáveis os profissionais dos CAPSi, dos Núcleos de internação Regulação das CAP (NIR) e/ou Equipes Multidisciplinares do Desenvolvimento Infantil. O agendamento deve levar em consideração os critérios de encaminhamento acima definidos e obedecer à regionalização por áreas de planejamento.

FLUXOGRAMA PARA AVALIAÇÃO DA CRIANÇA COM SUSPEITA DE AUTISMO - SMS-Rio



Fonte: SUBPAV, 2023

DOCUMENTOS

LAUDO

Os pacientes atendidos pelas equipes da Atenção Primária à Saúde receberão **RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO**, quando suspeitos, com validade de um ano e prorrogável por mais um ano; ou **LAUDO**



DIAGNÓSTICO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, para aqueles diagnosticados com TEA. A emissão está condicionada à avaliação clínica e utilização dos exames de rastreamento - anexos 3 e 4.

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM AUTISMO (CIPTEA)

Todo paciente diagnosticado com TEA terá direito à Carteira do Autismo emitida pela plataforma e aplicativo Minha Saúde Rio, mediante submissão dos dados requeridos. A Carteira do Autismo franqueará a seu portador os benefícios previstos na lei, entre outros. Os pacientes com em investigação receberão Carteira Provisória, com validade de um ano e prorrogável por mais um ano.

CONTRARREFERÊNCIA

Todo paciente avaliado pelas e-Multi e demais níveis especializados da atenção deve retornar à Atenção Primária à Saúde com o documento de contrarreferência (anexo 5) devidamente preenchido a fim de que o cuidado seja compartilhado e coordenado pela equipe de Saúde da Família.



Assinado com senha por RENATO CONY SERODIO - 12/09/2023 às 19:17:13 e LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO - 12/09/2023 às 19:18:10.
Autenticado digitalmente por RENATO CONY SERODIO - 12/09/2023 às 19:17:24.
Documento Nº: 3604635.26514968-3565 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3604635.26514968-3565>



SMSOFI202332745A

M-CHAT R (CHECKLIST MODIFICADO PARA AUTISMO EM CRIANÇAS PEQUENAS, VERSÃO REVISADA)

Realizar na consulta de puericultura de 18 meses, podendo ser antecipado para 16 meses nas crianças com quadro suspeito. As perguntas podem ser feitas na consulta ou entregues para preenchimento pelos familiares antes do atendimento.

1	Se você apontar para algum objeto no quarto, o seu filho olha para este objeto? (POR EXEMPLO, se você apontar para um brinquedo ou animal, o seu filho olha para o brinquedo ou para o animal?)	SIM	NÃO
2	Alguma vez você se perguntou se o seu filho pode ser surdo?	SIM	NÃO
3	O seu filho brinca de faz de contas? (POR EXEMPLO, faz de conta que bebe em um copo vazio, faz de conta que fala ao telefone, faz de conta que dá comida a uma boneca ou a um bichinho de pelúcia?)	SIM	NÃO
4	O seu filho gosta de subir nas coisas? (POR EXEMPLO, móveis, brinquedos em parques ou escadas)	SIM	NÃO
5	O seu filho faz movimentos estranhos com os dedos perto dos olhos? (POR EXEMPLO, mexe os dedos em frente aos olhos e fica olhando para os mesmos?)	SIM	NÃO
6	O seu filho aponta com o dedo para pedir algo ou para conseguir ajuda? (POR EXEMPLO, aponta para um biscoito ou brinquedo fora do alcance dele?)	SIM	NÃO
7	O seu filho aponta com o dedo para mostrar algo interessante para você? (POR EXEMPLO, aponta para um avião no céu ou um caminhão grande na rua)	SIM	NÃO
8	O seu filho se interessa por outras crianças? (POR EXEMPLO, seu filho olha para outras crianças, sorri para elas ou se aproxima delas?)	SIM	NÃO
9	O seu filho traz coisas para mostrar para você ou as segura para que você as veja – não para conseguir ajuda, mas apenas para compartilhar? (POR EXEMPLO, para mostrar uma flor, um bichinho de pelúcia ou um caminhão de brinquedo)	SIM	NÃO
10	O seu filho responde quando você o chama pelo nome? (POR EXEMPLO, ele olha para você, fala ou emite algum som, ou para o que está fazendo quando você o chama pelo nome?)	SIM	NÃO
11	Quando você sorri para o seu filho, ele sorri de volta para você?	SIM	NÃO
12	O seu filho fica muito incomodado com barulhos do dia a dia? (POR EXEMPLO, seu filho grita ou chora ao ouvir barulhos como os de liquidificador ou de música alta?)	SIM	NÃO
13	O seu filho anda?	SIM	NÃO
14	O seu filho olha nos seus olhos quando você está falando ou brincando com ele, ou vestindo a roupa dele?	SIM	NÃO
15	O seu filho tenta imitar o que você faz? (POR EXEMPLO, quando você dá tchau, ou bate palmas, ou joga um beijo, ele repete o que você faz?)	SIM	NÃO
16	Quando você vira a cabeça para olhar para alguma coisa, o seu filho olha ao redor para ver o que você está olhando?	SIM	NÃO
17	O seu filho tenta fazer você olhar para ele? (POR EXEMPLO, o seu filho olha para você para ser elogiado/aplaudido, ou diz: "olha mãe!" ou "óh mãe!")	SIM	NÃO
18	O seu filho compreende quando você pede para ele fazer alguma coisa? (POR EXEMPLO, se você não apontar, o seu filho entende quando você pede: "coloca o copo na mesa" ou "liga a televisão")?	SIM	NÃO
19	Quando acontece algo novo, o seu filho olha para o seu rosto para ver como você se sente sobre o que aconteceu? (POR EXEMPLO, se ele ouve um barulho estranho ou vê algo engraçado, ou vê um brinquedo novo, será que ele olharia para seu rosto?)	SIM	NÃO
20	O seu filho gosta de atividades de movimento? (POR EXEMPLO, ser balançado ou pular em seus joelhos)	SIM	NÃO

Algoritmo da pontuação: Para todos os itens, a resposta "NÃO" indica risco de TEA; exceto para os itens 2, 5 e 12, nos quais "SIM" indica risco de TEA. O algoritmo a seguir maximiza as propriedades psicométricas da MCHAT-R:
BAIXO RISCO: Pontuação Total entre 0-2; RISCO MÉDIO a ELEVADO: Pontuação Total entre 3-20; a criança deve ser encaminhada imediatamente para avaliação e, se confirmado o diagnóstico, intervenção precoce.



Assinado com senha por RENATO CONY SERODIO - 12/09/2023 às 19:17:14 e LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO - 12/09/2023 às 19:18:11.
Documento Nº: 3604635.26516012-2793 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3604635.26516012-2793>



SMSOFI202332745A

AQ-10 (QUOCIENTE DO ESPECTRO DO AUTISMO)

Realizar na consulta de crianças entre 4 e 11 anos de idade, como rastreamento ou na avaliação de caso suspeito. As perguntas podem ser feitas na consulta ou entregues para preenchimento pelos familiares antes do atendimento.

	PERGUNTA	CONCORDO TOTALMENTE	CONCORDO EM PARTE	DISCORDO EM PARTE	DISCORDO TOTALMENTE
1	Frequentemente percebo sons que outras pessoas não percebem				
2	Normalmente concentro-me mais nos pequenos detalhes do que na pintura completa				
3	Acho difícil fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo				
4	Se sou interrompido, não consigo voltar ao que estava fazendo facilmente				
5	Acho difícil "ler nas entre linhas" quando alguém está falando comigo				
6	Não sei dizer quando aborreço alguém com a minha conversa.				
7	Quando estou lendo uma história tenho dificuldade de prever as intenções dos personagens				
8	Gosto de colecionar informações sobre coisas (por exemplo, tipos de carros, trens, etc)				
9	Acho difícil prever o que as pessoas pensam ou sentem apenas olhando suas faces				
10	Acho difícil prever a intenção das pessoas				

Algoritmo da pontuação: Cote 1 ponto para cada resposta "Concordo totalmente" ou "Concordo parcialmente" nos itens 1, 5, 8 e 10. Cote 1 ponto por cada resposta "Discordo totalmente" ou "Discordo em parte" nos itens 2, 3, 4, 6, 7 e 9. Se o resultado final for superior a 6 (seis) pontos, considera-se alto risco para autismo.

SUBPAV, 2023. Adaptado do NICE Clinical Guideline CG142



Assinado com senha por RENATO CONY SERODIO - 12/09/2023 às 19:17:14 e LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO - 12/09/2023 às 19:18:12.
Documento Nº: 3604635.26516016-2789 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3604635.26516016-2789>



SMSOFI202332745A

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)

Unidade de saúde		
Usuário		
CPF	Data de Nasc.	Gênero ☐ Masc. ☐ Fem. ☐ Outro
Responsável		CPF
Endereço completo		
CEP	Telefones	

Instrumento(s) de Avaliação realizado(s) na consulta de acordo com idade
Pontuação M-Chat-R:
Pontuação AQ-10:
Outros (qual e pontuação):

Estágio da investigação de TEA (CID-10 F84.9) após avaliação
☐ Suspeição diagnóstica com base em instrumentos de avaliação.
☐ Em processo de investigação especializada.

Declaro que o usuário encontra-se em investigação diagnóstica nesta unidade de atenção primária à saúde por apresentar alterações suspeitas de atraso do desenvolvimento global infantil. Durante a investigação, gozará dos direitos conferidos pela Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo (CIPTEA) por 1 (um) ano, prorrogável por igual período. Após a investigação, caso o diagnóstico seja descartado, os efeitos da CIPTEA estarão suspensos.

Está encaminhado(a) para avaliação especializada no SISREG com código: _____

Assinatura/carimbo do profissional	Data
------------------------------------	------

Arte: Ascom/SMS-Rio • Atualizado em setembro de 2023



Assinado com senha por RENATO CONY SERODIO - 12/09/2023 às 19:17:15 e LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO - 12/09/2023 às 19:18:13.
Documento Nº: 3604635.26516021-2763 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3604635.26516021-2763>



SMSOF1202332745A

LAUDO DIAGNÓSTICO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)

Unidade de saúde		
Usuário		
CPF	Data de Nasc.	Gênero ☐ Masc. ☐ Fem. ☐ Outro
Responsável		CPF
Endereço completo		
CEP	Telefones	

Declaro que o paciente é acompanhado nesta unidade de saúde devido ao seu quadro clínico e, de acordo com a avaliação clínica, foram identificados sinais que o enquadram nos critérios para diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo (CID10: F84.0).

O usuário foi contrarreferenciado para sua unidade de atenção primária de referência a fim de ser encaminhado para unidade de reabilitação, pois necessita de estimulação precoce e suporte para melhor aproveitamento das atividades escolares.

Assinatura/carimbo do profissional	Data
------------------------------------	------

Arte: Ascom/SMS-Rio • Atualizado em setembro de 2023



Assinado com senha por RENATO CONY SERODIO - 12/09/2023 às 19:17:16 e LARISSA CRISTINA TERREZO MACHADO - 12/09/2023 às 19:18:13.
Documento Nº: 3604635.26516022-2762 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3604635.26516022-2762>



SMSOFI202332745A

